NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ NĂM 2011

NGUYỄN TUẤN HƯNG - *Bộ Y tế*

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí (BVVN-TĐUB) là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế với quy mô giường bệnh năm 2010 là 700 giường bệnh kế hoạch, số lượng lượt người đến khám bệnh là 154.761 lượt/năm, số người bệnh (NB) điều trị nội trú 36.295 người/năm. Trong hoạt động chăm sóc NB, bệnh viện đã có nhiều thành công trong việc áp dụng các mô hình chăm sóc NB toàn diện của điều dưỡng viên (ĐDV) và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc NB

Chăm sóc, theo dõi người bệnh là nhiệm vụ của bệnh viện, các hoạt động chăm sóc, theo dõi người bệnh do điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm. Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện bao gồm hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh nhằm duy trì hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, ăn uống, bài tiết, tư thế vận động, vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ; chăm sóc tâm lý; hỗ trợ điều trị và tránh các nguy cơ từ môi trường bệnh viện cho người bệnh.

Nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện: Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn. Can thiệp của điều dưỡng viên phải dựa trên cơ sở các yêu cầu chuyên môn và sự đánh giá nhu cầu của mỗi người bệnh để chăm sóc, phục vụ.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên như tuổi đời, giới tính, trình độ của điều dưỡng viên. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung và tại Bệnh viện VN-TĐUB nói riêng, để từ đó có sự bố trí, sử dụng điều dưỡng viên hợp lý và có các giải pháp khắc phục những mặt bất lợi của các yếu tố là góp phần vào việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên.

Chúng tôi thực hiện đề tài *"Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2011"*nhằm các mục tiêu sau:

1. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

2. Đề xuất một số khuyến nghị liên quan tới các yếu tố gây ảnh hưởng tới công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thiết kế nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.

2. Đối tượng nghiên cứu, thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Lãnh đạo: Bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Điều dưỡng và điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng.

- Điều dưỡng đội trưởng, điều dưỡng viên tại 15 khoa lâm sàng.

- Người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị ở 15 khoa lâm sàng, được chăm sóc bởi điều dưỡng viên trong đội tại thời điểm nghiên cứu.

- Số liệu thứ cấp: Các báo cáo thống kê về hoạt động chăm sóc người bệnh và chuyên môn của bệnh viện từ năm 2005 đến năm 2011.

2.2. Thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01 đến hết tháng 9 năm 2011.

2.3. Địa điểm nghiên cứu

Tại 15 khoa lâm sàng: thuộc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

3. Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu

3.1. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng

- Cỡ mẫu chủ đích: gồm 119 điều dưỡng viên và 33 điều dưỡng đội trưởng.

- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn cho đối tượng người bệnh và người nhà người bệnh bao gồm: 66 người bệnh và 33 người nhà người bệnh.

- Số liệu thứ cấp: Các báo cáo, thống kê về hoạt động chăm sóc người bệnh và chuyên môn của bệnh viện do phòng Điều dưỡng, phòng Tổ chức cán bộ và phòng Kế hoạch tổng hợp cung cấp.

3.2. Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính

Cỡ mẫu cho nghiên cứu định tính: 10 người, bao gồm lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo một số phòng chức năng, điều dưỡng trưởng khoa.

4. Phương pháp thu thập số liệu

- Phỏng vấn sâu dựa vào phiếu hướng dẫn phỏng vấn.

- Được thu thập thông qua bộ câu hỏi được thiết kế sẵn bán cấu trúc.

- Số liệu thứ cấp: Các báo cáo của phòng Điều dưỡng, các phòng Tổ chức cán bộ, của bệnh viện….

5. Phương pháp phân tích số liệu

- Số liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý và nhập vào máy tính với phần mềm Epi Data 3.1 và được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

1. Các yếu tố trực tiếp

Bảng 1: Thông tin chung của ĐDV

Thông tin chung		Số người (n=119)	Tỷ lệ (%)
Tuổi	<30	48	40,30
	30-50	47	39,50
	>50	24	20,20
Giới tính	Nam	9	7,60
	Nữ	110	92,40
Trình độ chuyên môn	Đại học	20	16,85
	Cao đẳng	26	21,85
	Trung cấp	73	61,30
	Sơ cấp	0	0,00
Thâm niên công tác	< 5 năm	31	26,10
	Từ 5-10 năm	58	48,70
	>10 năm	30	25,20

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, ĐDV có tuổi đời chủ yếu là dưới 30 tuổi (40,30%), từ 30-50 tuổi (39,50 %), trên 50 tuổi (20,2%); hầu hết ĐDV là nữ (92,40 %), chủ yếu có trình độ chuyên môn là trung cấp (61,30 %) và có thâm niên công tác từ 5 đến 10 năm (48,70%).

Bảng 2: Độ tuổi của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ

STT	Độ tuổi của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ của ĐDV	Không TX thực hiện	Thường xuyên thực hiện	OR (KTC 95%)	P
1	Giám sát NN hỗ trợ CSNB				
	≤ 50 tuổi	23	72	7,35(0,94 - 57,44)	0,029
	> 50 tuổi	1	23		
2	Tư vấn, hướng dẫn GDSK cho NB và NNNB có nhu cầu				
	≤ 50 tuổi	36	59	6,71(1,49 - 30,25)	0,006
	> 50 tuổi	2	22		
3	Ghi chép phiếu theo dõi NB trong quá trình điều trị				
	≤ 50 tuổi	0	95	1,04(0,96 - 1,13)	0,046
	> 50 tuổi	1	23		

Nhận xét: Độ tuổi của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ của ĐDV có ý nghĩa thống kê với các nhiệm vụ: Giám sát NNNB hỗ trợ chăm sóc NB (OR = 7,35; P<0,05); Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu cầu (OR = 6,71; P<0,05); Ghi chép phiếu theo dõi NB trong quá trình điều trị (OR = 1,04; P <0,05). Điều này có nghĩa là những ĐDV có độ tuổi trên 50 giám sát NNNB hỗ trợ chăm sóc NB, thường xuyên thực hiện cao gấp 7,35 lần so với các ĐDV có độ tuổi ≤ 50 giám sát NNNB hỗ trợ chăm sóc NB; ĐDVcó độ tuổi trên 50 tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu cầu, thường xuyên thực hiện cao gấp 6,71 lần so với ĐDV có độ tuổi ≤ 50 tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu cầu; ĐDV có độ tuổi trên 50 ghi chép phiếu theo dõi NB trong quá trình điều trị, thường xuyên thực hiện cao gấp 1,04 lần so với ĐDV có độ tuổi ≤ 50 ghi chép phiếu theo dõi NB trong quá trình điều trị.

Bảng 3. Độ tuổi của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ

STT	Độ tuổi của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ của ĐDV	Tự tin	Rất tự tin	OR (KTC 95%)	P
1	Rửa tay thường quy				
	≤ 50 tuổi	25	70	0,36 (0,14 - 0,90)	0,025
	> 50 tuổi	12	12		

Nhận xét: Độ tuổi của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ của ĐDV có ý nghĩa thống kê với nhiệm vụ: Rửa tay thường quy (OR = 0,36; P<0,05). Điều này có nghĩa là những ĐDV có độ tuổi trên 50 rửa tay thường quy, rất tự tin cao gấp 0,36 lần so với ĐDV có độ tuổi ≤ 50 rửa tay thường quy.

Bảng 4. Giới tính của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ

STT	Giới của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ	Không TX thực hiện	Thường xuyên thực hiện	OR (KTC 95%)	P
1	Chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB				
	Nam	1	8	0,13(0,02 - 1,11)	0,032
	Nữ	53	57		
2	Tham gia giám sát các hoạt động của đội				
	Nam	0	9	1,47(1,29 - 1,67)	0,044
	Nữ	35	75		

Nhận xét: Giới tính ĐDV điều dưỡng viên có ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ của ĐDV có ý nghĩa thống kê với các nhiệm vụ: Chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB (OR = 0,13; P<0,05); Tham gia giám sát các hoạt động của đội (OR = 1,47; P<0,05). Điều này có nghĩa là ĐDV là nữ giới chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB, thường xuyên thực hiện cao gấp 0,13 lần so với ĐDV là nam giới chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB; ĐDV là nữ giới tham gia giám sát các hoạt động của đội, thường xuyên thực hiện cao gấp 1,47 lần so với ĐDV là nam giới.

Bảng 5. Thâm niên công tác của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ

STT	Thâm niên công tác của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ của ĐDV	Không TX thực hiện	Thường xuyên thực hiện	OR (KTC 95%)	P
1	Theo dõi diễn biến người bệnh cần chăm sóc cấp I				
	≤ 10 năm	17	72	6,85 (0,87 - 53,85)	0,037
	> 10 năm	1	29		
2	Tư vấn, hướng dẫn GDSK cho NB và NNNB có nhu cầu				
	≤ 10 năm	34	55	4,02 (1,29 - 12,52)	0,012
	> 10 năm	4	26		
3	Tham gia đào tạo điều dưỡng				
	≤ 10 năm	64	25	2,93 (1,25 - 6,87)	0,012
	> 10 năm	14	16		

Nhận xét: Thâm niên công tác của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ thực hiện nhiệm vụ của ĐDV có ý nghĩa thống kê với: Theo dõi diễn biến NB cần chăm sóc cấp I (OR = 6,85; P<0,05); Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu cầu (OR = 4,02; P<0,05); Tham gia đào tạo ĐD (OR = 2,93; P <0,05). ĐDV có thâm niên công tác trên 10 năm theo dõi diễn biến NB cần chăm sóc cấp I, thường xuyên thực hiện cao gấp 6,85 lần so với ĐDV có thâm niên công tác ≤ 10 năm; ĐDV có thâm niên công tác trên 10 năm tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu cầu, thường xuyên thực hiện cao gấp 4,02 lần so với điều dưỡng viên có thâm niên công tác ≤ 10 năm tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho NB và NNNB có nhu

cầu; ĐDV có thâm niên công tác trên 10 năm tham gia đào tạo ĐD, thường xuyên thực hiện cao gấp 2,93 lần so với ĐDVcó thâm niên công tác ≤ 10 năm.

Bảng 6. Trình độ chuyên môn của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ

STT	Trình độ chuyên môn của ĐDV ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ	Tự tin	Rất tự tin	OR (KTC 95%)	P
1	Rửa tay thường quy				
	Đại học, cao đẳng	9	37	0,39(0,16 - 0,93)	0,031
	Trung cấp	28	45		
2	Chăm sóc phục hồi chức năng cho NB				
	Đại học, cao đẳng	23	23	0,46(0,22 - 0,98)	0,044
	Trung cấp	50	23		
3	Giao tiếp và hướng dẫn học sinh/sinh viên thực tập tại BV				
	Đại học, cao đẳng	16	30	0,44(0,21 - 0,94)	0,033
	Trung cấp	40	33		

Nhận xét: Trình độ chuyên môn của ĐDV có ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ của ĐDV có ý nghĩa thống kê với các nhiệm vụ: Rửa tay thường quy (OR = 0,39; P<0,05); Chăm sóc phục hồi chức năng cho NB (OR = 0,46; P<0,05); Giao tiếp và hướng dẫn học sinh/sinh viên thực tập tại bệnh viện (OR = 0,44; P<0,05). Điều này có nghĩa là ĐDV có trình độ trung cấp rửa tay thường quy, rất tự tin cao gấp 0,39 lần so với ĐDV có trình độ đại học, cao đẳng; ĐDV có trình độ trung cấp chăm sóc phục hồi chức năng cho NB, rất tự tin cao gấp 0,46 lần so với ĐDV có trình độ đại học, cao đẳng. ĐDV có trình độ trung cấp giao tiếp và hướng dẫn học sinh/sinh viên thực tập tại bệnh viện, rất tự tin cao gấp 0,44 lần so với ĐDV có trình độ đại học, cao đẳng.

2. Một số yếu tố gián tiếp khác

2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế

Các trang thiết bị bố trí trong buồng bệnh chưa hợp lý có ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc NB: "*Với trẻ nhi chúng tôi phải thực hiện các thủ thuật tiêm truyền tại phòng cấp cứu vì giường bệnh tại bệnh phòng thấp và không đủ ánh sáng để lấy ven bệnh nhi. Tại bệnh phòng các trang thiết bị vẫn chưa được thuận tiện và đáp ứng được nhu cầu làm việc của điều dưỡng viên*"(ĐD trưởng khoa, khối Nhi).

Thiếu trang thiết bị y tế chuyên dụng ở một số khoa cũng làm ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc NB của ĐDV: "*Để thuận tiện hơn nữa thì các trang thiết bị như thiết bị thở ô xy trên tường nên được trang bị đầy đủ hơn nữa. Đối với xe lăn mới chỉ có một chiếc, nên có thêm vài ba chiếc nữa để thuận tiện cho việc đưa đón người bệnh*"(ĐD trưởng khoa, khối Ngoại).

2.2. Lương và phụ cấp hàng tháng

Lương thấp, chưa có phụ cấp hàng tháng cho ĐDV. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc của ĐDV:*"Dù sao trong quá trình làm việc vẫn có những than vãn là lương thấp, trực thấp, như chúng tôi chẳng hạn chỉ có lương có thưởng còn những chị em mới vào làm hợp đồng tổng thu nhập mới chỉ được khoảng 2 triệu đồng/tháng thôi. Với thu nhập đó, với bề mặt sinh hoạt chung của xã hội thì bảo rằng họ cống hiến hết mình, tôi nghĩ rằng không giám đốc, trưởng khoa nào, không điều dưỡng trưởng nào bắt họ phải cống hiến hết mình"*(ĐD trưởng khoa).

2.3. Chính sách thu hút nguồn nhân lực ĐD

Chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực ĐD cũng có thể có tác động đến hoạt động chăm sóc NB của ĐDV: "*Hiện tại thì bệnh viện chưa có chính sách gì để thu hút điều dưỡng viên, mới chỉ có chính sách thu hút bác sỹ"*(LĐ phòng TCCB).

2.4. Khen thưởng, kỷ luật

Khen thưởng ĐDV chưa thường xuyên và kịp thời cũng là yếu tố ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của ĐDV:*"Với khen thưởng đột xuất thì hiện tại cả cơ quan vẫn ít, đặc biệt với điều dưỡng. Hiện tại trong năm vừa qua cũng như từ đầu năm đến bây giờ thì thưởng đột xuất cho các đội này vẫn còn hạn chế. Theo mình nay mai tất cả các khoa cũng phải có ý kiến chỗ này để trong 1 quý hoặc trong 6 tháng chọn một số nhân tố điển hình để trình giám đốc khen thưởng*"(LĐ phòng TCCB).

KẾT LUẬN

Độ tuổi, giới, thâm niên công tác của điều dưỡng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ và hiệu quả thực hiện trong một số nhiệm vụ của điều dưỡng viên.

Độ tuổi, thâm niên công tác và trình độ chuyên môn của điều dưỡng viên có ảnh hưởng đến mức độ tự tin khi thực hiện trong một số nhiệm vụ của điều dưỡng.

Một số yếu tố gián tiếp như: chế độ chính sách đãi ngộ, cơ sở vật chất của cơ sở làm việc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chăm sóc NB của ĐĐV.

KHUYẾN NGHỊ

- Cần phát hiện, rà soát, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên để từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của các yếu tố đó để bố trí điều dưỡng viên đảm nhận các vị trí việc làm phù hợp với độ tuổi, trình độ, giới tính của điều dưỡng viên từ đó góp phần duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc NB của ĐDV tại bệnh viện.

- Động viên, khích lệ kịp thời bằng khen thưởng, chế độ lương thưởng phù hợp đối với điều dưỡng viên để tạo không khí làm việc thân thiện, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (2010), *Báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện năm 2010*, Uông Bí.

2. Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (2009) *Một số quy định về thực hiện mô hình đội chăm sóc tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí*, Uông Bí.

3. Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (2011), *Quyết định số 153/QĐ-BV ngày 02/01/2011 về việc giao nhiệm vụ đội trưởng đội chăm sóc tại các khoa lâm sàng*.

4. Bộ Nội vụ (2005), *Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng*.

Bộ Y tế-Bộ Nội vụ (2007), *Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT/BYT-BNV ngày 5/6/2007 về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.*.

5. Bộ Y tế (2011), *Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện*.

6. Bộ Y tế (2004), *Tài liệu quản lý điều dưỡng,* Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội, tr.166-358.